Bài : CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Mục tiêu:

1. Trình bày được định nghĩa về môi trường (MT), các thành phần của MT, các yếu tố MT chính tác động lên đời sống sinh vật.

2. Trình bày được thực trạng MT ở Việt Nam hiện nay, kế hoạch quốc gia về MT và phát triển lâu bền của Việt Nam.

3. Trình bày được định nghĩa về sức khỏe (SK), sức khỏe môi trường, mối liên quan giữa các yếu tố MT và SK.

4. Trình bày được các bệnh tật liên quan đến MT, các biện pháp phòng chống ô nhiễm MT, nâng cao SK.

NỘI DUNG:

1.Khái niệm về môi trường :

1.1. Định nghĩa về môi trường:

-Theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam(2005): môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Các thành phần của môi trường bao gồm:

-Môi trường lý học bao gồm các yếu tố vật lý như: khí hậu, bụi, tiếng ồn, ánh sáng, bức xạ…

-Môi trường hóa học gồm: các yếu tố hoá học, hơi khí độc, hoá chất, thuốc men, thực phẩm…

-Môi trường sinh học bao gồm: động vật, thực vật, ký sinh trùng, vi khuẩn, virut, bào tử nấm…

-Môi trường xã hội bao gồm : các căng thẳng xã hội (stress), các mối quan hệ giữa con người với con người, môi trường làm việc, gia đình, cộng đồng, yếu tố giàu nghèo, việc làm, thu nhập, công bằng xã hội, các dịch vụ xã hội: y tế, trường học, vui chơi giải trí, đi lại, ăn ở, an sinh xã hội, tai nạn, tệ nạn, bạo lực…

- Môi trường sống là sự tổng hợp những điều kiện vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế, xã hội học…bao quanh con người và có ảnh hưởng tới sự sống, sự phát triển của từng cá nhân hay của cộng đồng con người
- Mỗi cơ thể, quần thể sinh vật đều sống dựa vào môi trường đặc trưng của mình, ngoài môi trường đó ra, sinh vật không thể tồn tại.
- Môi trường ổn định thì sinh vật sẽ sống ổn định và phát triển hưng thịnh.

- Môi trường suy thoái thì sinh vật cũng suy thoái cả về số lượng và chất lượng.
- Môi trường bị hủy hoại thì sinh vật cũng chịu chung số phận.

1.2.Phân loại môi trường:

- Phân loại theo sự sống:

+ Môi trường vật lý: là thành phần vô sinh của môi trường tự nhiên gồm thạch quyển, thủy quyển, khí quyển, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người.

+ Môi trường sinh học; là thành phần hữu sinh của môi trường, là môi trường ở đó diễn ra sự sống.

- Theo tác nhân:

+ Môi trường tự nhiên: là môi trường do thiên nhiên tạo ra (sông, biển,đất, nước, không khí…)

+ Môi trường nhân tạo: là môi trường do con người tạo ra và chịu ảnh hưởng của con người (môi trường đô thị, làng mạc,kênh đào, chợ búa, trường học…)

+ Môi trường xã hội là môi trường hoạt động xã hội của con người, bao gồm các mối quan hệ giữa người với người (môi trường giáo dục, hoạt động xã hội về văn hóa, nghệ thuật, thể chế chính trị…)

1.3.Các yếu tố môi trường chính ảnh hưởng tới đời sống sinh vật:

1.3.1.Nhiệt độ : là yếu tố sinh thái quan trọng, ảnh hưởng tới quá trình sinh lý, sinh thái, tập tính của sinh vật. Sự sống chỉ tồn tại trong 1 giới hạn nhiệt độ rất hẹp (âm 200^0C đến dương 100^0C:hạt cây chứa 6-12% nước để trong không khí lạnh âm 193^0C sau 1 thời gian vẫn nẩy mầm…), đa số các loài sống trong phạm vi từ 0^0C đến 50^0C.

1.3.2.Ánh sáng:là yếu tố sinh thái quan trọng đối với sinh vật, ánh sáng để thực vật quang hợp tạo chất hữu cơ, tạo chu kỳ ngày đêm, chu kỳ mùa của sinh vật.

1.3.3. Nước và độ ẩm: Nước là điều kiện sống còn của sinh vật. Trên 70% trọng lượng cơ thể sinh vật là nước. Nước cùng với nhiệt độ (chế độ nhiệt ẩm) chi phối sự phân bố của các đới sinh vật trên trái đất (sinh vật ưa ẩm, chịu hạn, ôn đới, nhiệt đới)

1.3.4.Các chất khí: tham gia vào quá trình quang hợp và hô hấp của sinh vật. Sự thay đổi thành phần các chất khí làm thay đổi quá trình quang hợp và hô hấp của sinh vật, ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật.

1.3.5.Các muối dinh dưỡng: tham gia vào cấu trúc của cơ thể sinh vật, là yếu tố điều hòa các quá trình sinh hóa của cơ thể.Thiếu hay thừa các muối đều có hại cho sinh vật

1.4.Thực trạng những vấn đề về môi trường ở Việt nam hiện nay.

1.4.1.Quá trình đô thị hóa:

- Đô thị hóa là quá trình tập trung nhân lực (con người), vật lực (tài nguyên, của cải) để phát triển kinh tế xã hội tại một khu vực không gian nhất định.

- Đô thị hóa vì vậy làm tăng mật độ dân cư, khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên, hậu quả là gây ô nhiễm môi trường sống của con người:

+ Thừa chất thải: rác thải, nước thải, khí thải

+ Thiếu nước sạch,thực phẩm sạch, khí sạch, đất sạch.

+Nhà ở tồi tàn, chật chội, ô nhiễm, mất vệ sinh

+Thiếu cơ sở hạ tầng: trường học, bệnh viện, nơi vui chơi…

+Tắc nghẽn giao thông, tai nạn thương tích…

+Căng thẳng xã hội, tệ nạn, tội phạm, mất công bằng…

- Tất cả các yếu tố này đều tác động xấu đến sức khỏe, làm suy giảm chất lượng sống của con người. Đây là mặt trái của đô thị hóa.

1.4.2.Sản xuất năng lượng:

- Phát triển kinh tế xã hội càng tăng thì năng lượng tiêu thụ càng cao
- Để có đủ năng lượng, ngoài các nguồn năng lượng sạch (thủy điện, gió, mặt trời), đã khai thác và sử dụng tối đa nguồn năng lượng hóa thạch (than, dầu mỏ, khí đốt) và khai thác gỗ củi gây tàn phá rừng, gây ô nhiễm bởi khói bụi, hơi khí độc khi đốt nhiên liệu lấy năng lượng. Nguy cơ gây ô nhiễm chất phóng xạ khi sử dụng năng lượng hạt nhân

1.4.3.Phát triển nông nghiệp, thủy lợi:

- Để cung cấp đủ lương thực cho dân số ngày một tăng:

+Đã khai thác tối đa đất nông nghiệp, gây giảm độ phì nhiêu, sói mòn, sa mạc hóa.

+Sử dụng các hóa chất kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu diệt cỏ, gây ô nhiễm môi trường

- Phát triển thủy lợi, tích nước, đã làm thay đổi nhiều vùng sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của nhiều cộng đồng dân cư.

1.4.4.Khai thác khoáng sản,tài nguyên rừng biển:

Để phát triển kinh tế xã hội cần sử dụng nhiều tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng biển,gây cạn kiệt nguồn tài nguyên,ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái,tuyệt chủng nhiều loài sinh vật, mất các nguồn gien quý

1.4.5.Sức ép dân số:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm trên 1%.
- Tỷ lệ tăng không đều giữa thành phố, đồng bằng, trung du và miền núi.
- Nguyên nhân tăng nhanh dân số do:

+Trình độ dân trí còn thấp

+Nhiều hủ tục tồn tại

+Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình chưa bền vững.

- Phát triển kinh tế không theo kịp phát triển dân số, gây nhiều căng thẳng trong xã hội (thiếu việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện…)

1.4.6.Tài nguyên đất ngày càng suy giảm:

Diện tích đất dùng cho trồng trọt chỉ bằng 1/5 (cả nước có gần 7 triệu ha đất nông nghiệp), bình quân đất nông nghiệp đầu người thấp nhất khu vực và ngày càng bị thu hẹp và thoái hóa do nhiễm mặn, phèn, ngập nước, sói mòn, sa mạc hóa

1.4.7.Tài nguyên nước bị suy giảm:

- Việt nam có lượng mưa lớn nhưng phân bố không đều giữa các mùa và vùng miền
- Chỉ có 20-40% hộ gia đình có nước sạch sử dụng.

-Tài nguyên nước đang bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng do:

+ Khai thác sử dụng quá mức nguồn nước mặt và nước ngầm (không được quản lý chặt)

+ Nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, nông nghiệp

1.4.8.Suy giảm tài nguyên rừng:

- Diện tích rừng tự nhiên giảm sút nhanh (1943, diện tích rừng chiếm 60% diện tích tự nhiên, 1945 còn 45% diện tích, 1992 còn 28% diện tích tự nhiên)

1.4.9.Tài nguyên biển bị suy giảm:

- Bờ biển dài 3500 km, thành phần giống loài thủy sản nhiều nhưng số lượng cá thể trong loài ít, phân bố không tập trung, biến động theo mùa, sản lượng khoảng 1 triệu tấn/ năm.
- Ngày càng cạn kiệt do khai thác không có kế hoạch, ô nhiễm và phá hủy môi trường (rừng ngập mặn), khai thác dầu khí, dùng thuốc nổ…

1.4.10.Các vấn đề suy thoái khác:

- Suy thoái đa dạng sinh học: suy giảm nguồn gien, nhiều loài tiệt chủng.
- Đô thị hóa và di dân tự do.
- Môi trường ô nhiễm ngày càng tăng.

1.5.Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển lâu bền của Việt nam.

1.5.1.Quan điểm:

- Phát triển bền vững : sử dụng tổng hợp tài nguyên, liên kết chặt chẽ tài nguyên với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thỏa mãn nhu cầu cơ bản về vật chất tinh thần văn hóa cho các thế hệ hiện tại và tương la

- Chiến lược bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng và người dân.
- Bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, lâu dài
- Tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật đi đôi với việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của người dân và xã hội

- Mang tính quốc gia, khu vực, toàn cầu và hợp tác quốc tế.

1.5.2.Mục tiêu đến năm 2020:

- 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
- 100% khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường
- Hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải, phấn đấu 30% chất thải thu gom được tái chế.
- 100% dân đô thị, 95% dân nông thôn được sử dụng nước sạch

- Tỷ lệ đất có rừng che phủ đạt 48% diện tích tự nhiên cả nước.
- 100% sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, 50% hàng hóa tiêu dùng trong nước ghi nhãn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14021.

1.5.3.Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản:

- **Nhiệm vụ:**

+Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm

+Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng.

+Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên

+Bảo vệ và cải thiện môi trường các khu vực trọng điểm

- **Giải pháp:**

+Tuyên truyền giáo dục

+Tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật về bảo vệ môi trường

+Áp dụng các công cụ quản lý kinh tế trong quản lý môi trường

+Đa dạng hóa đầu tư bảo vệ môi trường

+Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ bảo vệ môi trường

+Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

+Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường.

2.Định nghĩa về sức khoẻ :

-Theo tổ chức Y tế thế giới (1978):

“Sức khoẻ là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là một tình trạng không bệnh tật hay tàn tật”

-Theo Bác Hồ (Hồ Chí Minh, Báo Cứu quốc số 199 ra ngày 27/3/1946 và Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 212) :

“Khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ”

Sức khoẻ là sự kết hợp hài hoà cả 3 thành phần : thể chất, tâm thần, xã hội.

-Sức khoẻ thể chất là :

+ Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể…) cân đối, phù hợp với tuổi và giới. Người béo quá hay gầy quá đều có sức khoẻ thể chất không tốt.

+ Có thể lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sức dai, khéo léo…) phù hợp với tuổi giới. Người chậm chạp quá, nhanh mệt, nhanh xuống sức…là có sức khoẻ thể chất không tốt.

-Sức khoẻ tâm thần là :

Có khả năng tự làm chủ được bản thân, luôn giữ được cân bằng trong lý trí và tình cảm trước mọi thay đổi không ngừng của môi trường bên ngoài.

-**Sức khoẻ xã hội là :**

Có khả năng hoà nhập với môi trường xã hội xung quanh, có khả năng tác động cải tạo lại môi trường đó.

Để đánh giá sức khoẻ của một cá nhân, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau :

-Đo các chỉ tiêu về thể lực : chiều cao, cân nặng, lực bóp cánh tay…

-Đo các chỉ tiêu chức năng : mạch, huyết áp, dung tích sống, thị lực, thính lực, điện não đồ, chức năng gan, chức năng thận…

Để đánh giá sức khoẻ của một cộng đồng, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau :

-Tính tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ chết trẻ em, thời gian sống bị mất đi do ốm đau bệnh tật(YLL- Year Life Loss)…

3. Định nghĩa về sức khoẻ môi trường

- Theo định nghĩa của WHO (1993) “ Sức khỏe môi trường bao gồm tất cả những khía cạnh liên quan tới sức khỏe, tình trạng ốm, bị bệnh và bị thương tật của con người do phải chịu tác động từ các yếu tố môi trường vật lý, hóa học, sinh học, xã hội và tâm lý. Thuật ngữ này đồng thời cũng được dùng để gọi chung cho các lý thuyết và thực hành về đánh giá, điều chỉnh, kiểm soát và phòng ngừa những yếu tố của môi trường có khả năng gây nên những tác động có hại cho sức khỏe con người, cả thế hệ hiện tại và các thế hệ trong tương lai.”

-Theo định nghĩa trong “Chiến lược Sức khoẻ Môi trường Quốc gia của Australia – 1999”:

“Sức khoẻ môi trường là các vấn đề về sức khoẻ của con người (bao gồm cả chất lượng cuộc sống) do các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, xã hội và các yếu tố tâm lý trong môi trường gây nên.”

-Nghiên cứu và thực hành về sức khoẻ môi trường là:

+Nghiên cứu các yếu tố môi trường, các tác nhân, các nguồn gây ô nhiễm môi trường(đánh giá môi trường)

+Và các vấn đề thay đổi của sức khoẻ con người dưới tác động của các yếu tố môi trường (đánh giá sức khoẻ),

+Đề xuất các giải pháp can thiệp vào môi trường và sức khỏe nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ của cộng đồng

Sức khoẻ môi trường là môn học nền tảng, cốt lõi của Y học dự phòng, Y tế công cộng

+ Cung cấp các cơ sở khoa học, lý luận cơ bản để mô tả, giải thích, làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa môi trường và sức khoẻ trong quá khứ, hiện tại và tương lai

+Đề xuất các giải pháp can thiệp làm sạch môi trường, tăng cường và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ của con người.

+Đo lường sức khoẻ môi trường trong hiện tại sẽ là căn cứ để dự báo mô hình sức khoẻ bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giải pháp can thiệp chủ động để nâng cao sức khoẻ trong tương lai.

4. Các yếu tố của môi trường tác động đến sức khoẻ :

4.1. Mô hình các yếu tố môi trường tác động đến sức khoẻ (Mô hình Dahlgren & White head, 1998):

Hoà bình - ổn định chính trị - Phát triển kinh tế - Công bằng
Y tế- Việc làm- Nước sạch- Nhà ở- Khẩu phần ăn- Giáo dục
Thuốc lá- Rượu- Ma tuý- Tình dục- Chế độ ăn- Thể dục
Mạng lưới an sinh xã hội

Tuổi- Giới tính-Yếu tố di truyền

4.2.Các yếu tố tác động đến sức khoẻ :

4.2.1. Các yếu tố di truyền, bẩm sinh :

- Có các bệnh di truyền từ cha mẹ sang con cái: bệnh ưa chảy máu…, có các dị tật bẩm sinh như sứt môi hở hàm, thừa ngón chân, ngón tay...

- Cha mẹ bị bệnh tật sẽ có nguy cơ cao sinh ra con cái bị bệnh tật.

- Hiện tại các giải pháp tác động lên bộ máy di truyền để sửa chữa các sai lạc trên gen, phòng tránh các bệnh di truyền còn hạn chế và tốn kém.

- Người ta chủ động phòng tránh các yếu tố tác hại trong quá trình mang thai để hạn chế các dị tật bẩm sinh.

4.2.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe :

4.2.2.1. Các yếu tố môi trường tự nhiên

-Các yếu tố môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học của môi trường

-Theo WHO tất cả các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của con người đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe của con người.

- **Những thay đổi về vi khí hậu**: nơi ở, nơi làm việc có ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất lao động : quá nóng, quá lạnh, quá ẩm, quá khô làm căng thẳng quá trình điều nhiệt, suy giảm sức đề kháng, gây các bệnh theo mùa, tăng các bệnh liên quan đến thời tiết.

- - **Ô nhiễm không khí nơi ở, nơi làm việc:** do khí thải, nước thải, rác thải, do sinh hoạt, đun nấu, nghề phụ, từ các công trình vệ sinh, do ô nhiễm tại các khu công nghiệp , giao thông, xử lý chất thải, thải ra khói bụi, hơi khí độc, các loại vi khuẩn nấm mốc gây bệnh, gây ô nhiễm, gia tăng các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.
- - **Ô nhiễm nguồn nước:** Chất thải từ khu dân cư , khu công nghiệp, làm ô nhiễm các nguồn nước mặt, ngầm, làm cho nguồn nước bị nhiễm các chất độc hại : chất hữu cơ, hoá chất độc, kim loại nặng, vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh, làm gia tăng các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước.

- **Ô nhiễm môi trường đất :** do nước thải, rác thải từ khu dân cư, khu công nghiệp, do phân bón, các hoá chất trừ sâu diệt cỏ, gây ô nhiễm nguồn nước, tích luỹ trong các sản phẩm nông nghiệp , qua chuỗi thức ăn vào cơ thể, ảnh hưởng xấu cho sức khoẻ

- **Suy thoái môi trường, mất cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học:** do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất và đời sống, làm cạn kiệt tài nguyên.

4.2.2.2. Các yếu tố môi trường xã hội :

- **Dân số:**

+Chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình có ảnh hưởng mạnh đến sức khoẻ, nhất là phụ nữ và trẻ em.

+Sự phân bố dân cư ở mỗi vùng khác nhau có ảnh hưởng đến sức khoẻ của cá nhân và cộng đồng: đô thị mật độ dân cư cao, chật trội, quá tải cơ sở hạ tầng, vùng sâu, xa, giao thông khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp, tiếp cận dịch vụ y tế khó khăn.

+Tình trạng di dân tự do, điều kiện sống thay đổi, thiếu dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cá nhân và cộng đồng

- **Kinh tế thu nhập, nghề nghiệp, việc làm:**

+Thu nhập có ảnh hưởng quan trọng đối với sức khoẻ vì nó quyết định mức sống của mỗi cá nhân và gia đình, việc làm ổn định , thu nhập tăng thì tình trạng sức khoẻ được cải thiện. Việc làm không ổn định, nghề nghiệp nhiều rủi ro, thu nhập thấp làm giảm sút sức khoẻ, nhất là phụ nữ và trẻ em

+Tính chất công việc, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, cường độ lao động, điều kiện lao động, nguy cơ tiếp xúc với độc hại , tai nạn lao động, bảo hộ lao động, liên quan tới sức khỏe.

Chỗ ở:

+Có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người từ khi sinh ra cho đến khi chết, là môi trường trực tiếp bảo vệ sức khoẻ mỗi cá nhân về cả 3 mặt thể chất tinh thần và xã hội.

+Người nghèo ở trong căn nhà tồi tàn, điều kiện vệ sinh kém, ô nhiễm, thiếu nước sạch, không xử lý phân rác, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, dễ bị các căng thẳng, không có điều kiện được chăm sóc

- Các yếu tố văn hoá:

+Trình độ văn hoá: ảnh hưởng đến hiểu biết, thái độ, thực hành đối với sức khoẻ và việc bảo vệ sức khoẻ của cá nhân và cộng đồng

+**Phong tục tập quán :** phong tục tập quán ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khoẻ, có thói quen ảnh hưởng tốt cho sức khoẻ , có thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

-An sinh xã hội và gia đình:

+Sự hỗ trợ xã hội, các mối quan hệ gần gũi, thân thiện có tác dụng bảo vệ sức khoẻ cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

+Ngược lại các mâu thuẫn trong gia đình, cộng đồng, xã hội bao giờ cũng gây ra các gánh nặng tâm lý(stress) ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ tâm thần.

4.2.2.3. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ y tế:

- Màng lưới tổ chức y tế:

+ Sự phân bố các cơ sở y tế: ở các đô thị lớn, có mạng lưới y tế tốt hơn về mọi mặt: cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ cán bộ y tế, làm cho chất lượng chăm sóc dịch vụ tốt hơn cả về dự phòng và điệu trị so với vùng khác.

+Với người nghèo, vùng nghèo, dịch vụ y tế, thường không được tốt như người ta mong muốn.

+Hệ thống y tế ngoài công lập có vai trò quan trọng đáp ứng dịch vụ y tế của người dân, cần định hướng chăm sóc sức khoẻ toàn diện, không chỉ vì lợi nhuận.

-Khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế:

+Người nghèo thường không biết khai thác các dịch vụ y tế sẵn có, thiếu tiền, phương tiện cá nhân để tiếp cận dịch vụ y tế khi cấp bách, không có cách lựa chọn theo ý muốn.

+Sự hưởng thụ lợi ích không đồng đều giữa các tầng lớp dân cư. Mức độ sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao của những người khá giả cao hơn nhiều so với những người nghèo.

+Nguyên nhân chính khiến người nghèo ít sử dụng dịch vụ y tế là do các rào cản về tài chính(chi phí dịch vụ y tế lớn, khả năng chi trả của thấp), rào cản địa lý(miền núi, vùng sâu, vùng xa), rào cản về văn hoá, phong tục tập quán.

4.2.2.4. Lối sống cá nhân và cộng đồng :

- Các yếu tố tâm lý(nhân cách, cảm xúc) :

+Tình trạng cảm xúc âm tính khiến cho con người có những hành vi có hại cho sức khoẻ, gây bệnh như hút thuốc lá, uống rượu để giải sầu. Cảm xúc âm tính(lo lắng, thù địch) dễ đưa đến một loạt bệnh tâm thể(tim mạch, loét dạ dày tá tràng…)

- **Các yếu tố hành vi:**

+Người nghèo dễ ngả theo các hành vi có hại cho sức khoẻ như hút thuốc lá và nghiện rượu…

+Các yếu tố hành vi (do kiến thức, thái độ, thực hành và niềm tin tạo thành).

+Hành vi có lợi cho sức khoẻ: như rửa tay trước khi ăn, tập thể dục thường xuyên…

+Hành vi gây hại cho sức khoẻ như ăn uống quá độ, quan hệ tình dục bừa bãi, hút thuốc lá ở nơi công cộng…

-**Lối sống** (là các hành vi, thói quen, các niềm tin, giá trị của cá nhân, các đặc trưng như tuổi, giới...) duy trì sức khoẻ tốt như:

+Bản thân làm chủ được việc làm và các điều kiện sống của mình.

+Có đủ khả năng về tâm lý và hành vi để đối phó được với các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống

+Có quan hệ tốt với xã hội, có khả năng kiểm soát được cuộc sống của chính bản thân mình.

5. Mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khoẻ :

5.1. Những yếu tố môi trường gây nguy hại cho sức khoẻ :

Mọi biến đổi của môi trường đều tác động tới sức khoẻ.

Người ta chia các yếu tố môi trường thành 2 nhóm chính :

- **Các yếu tố truyền thống** (nghèo nàn, lạc hậu):

+Thiếu nguồn nước sạch

+Vệ sinh môi trường kém

+ Nước thải, rác thải không được thu gom, xử lý

+ Ô nhiễm không khí

+ Thực phẩm bị ô nhiễm

+ Lao động trong điều kiện lạc hậu, ô nhiễm…

+ Các thảm hoạ thiên nhiên: lũ lụt, hạn hán…

-**Các yếu tố hiện đại** (do phát triển không bền vững):

+ Ô nhiễm không khí (do công nghiệp, giao thông, ô nhiễm tiếng ồn..)

+ Ô nhiễm đất (do nước thải , rác thải công nghiệp...)

+ Tai nạn (do giao thông, sản xuất, sinh hoạt...)

+ Ô nhiễm môi trường (do hoá chất công nghiệp, hoá chất trừ sâu trong nông nghiệp)

+ Ô nhiễm thực phẩm (do hoá chất dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến...)

+ Tài nguyên cạn kiệt, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học...

+ Thay đổi toàn cầu: mưa axít, lỗ thủng tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ trái đất, biến đổi khí hậu, gây thảm hoạ thiên nhiên: hạn hán, lũ lụt…

+ Lối sống không lành mạnh: ăn uống không hợp lý, bia rượu, thuốc lá, nhiều thịt, mỡ, đồ ngọt, làm việc căng thẳng, ít vận động, ma tuý, tình dục không an toàn...

-Tác động các nguy cơ hiện đại thường biểu hiện từ từ, lặng lẽ, tiềm tàng, khó nhận biết và khi phát hiện ra thì đã có hậu quả như nhiễm độc nghề nghiệp, ungthư, tăng đường huyết, tăng huyết áp, suy nhược thần kinh…

-Giữa nguy cơ truyền thống và nguy cơ hiện đại có sự khác biệt. Tác động của nguy cơ truyền thống thường nhanh, biểu hiện ở dạng bệnh tật, dễ được phát hiện và phòng tránh như dùng nước bẩn gây tiêu chảy, các bệnh về da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục…

5.2. Những yếu tố truyền thống phổ biến hiện nay :

5.2.1. Thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém :

Thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém là nguyên nhân trực tiếp của nhiều bệnh, nhất là các bệnh đường tiêu hoá.

+Trung bình mỗi năm Việt nam có 1 triệu ca tiêu chảy, có 88% ca tiêu chảy là do thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém.

+ Tại các vùng nông thôn, có 80% học sinh tiểu học bị nhiễm giun. Các bệnh mắt hột, viêm nhiễm ngoài da, viêm nhiễm đường sinh dục của phụ nữ tăng cao.

5.2.2. Ô nhiễm không khí trong nhà ở :

-Ô nhiễm không khí trong nhà (Nguyên nhân chính là do đun nấu bằng than củi không được thông khí tốt, nhà cửa không thông thoáng, ẩm thấp, gần chuồng gia súc)

- Phụ nữ, trẻ em và người già là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất (do thời gian ở nhà và làm việc nhà nhiều nhất). Theo WHO : ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân của 35,7% trường hợp viêm đường hô hấp dưới, 22% các bệnh phổi mãn tính.

5.2.3. Ô nhiễm môi trường đất, nước do nước thải, rác thải không được thu gom xử lý :

-Lượng nước thải, rác thải ngày càng tăng, luôn mang theo một lượng lớn các chất ô nhiễm, các mầm bệnh từ phân, chất thải của người và gia súc, làm ô nhiễm đất, nước, thức ăn,

-Làm gia tăng các bệnh đường tiêu hoá, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ.

-Làm gia tăng các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, giun chỉ, viêm não Nhật bản, sốt rét…

5.3. Những yếu tố môi trường hiện đại :

5.3.1. Ô nhiễm đất, nước do hoá chất độc :

-Các hoá chất độc có trong nước thải, rác thải công nghiệp, các hoá chất trừ sâu diệt cỏ, được thải vào môi trường chưa qua xử lý ngày càng tăng về số lượng và chủng loại gây ô nhiễm.

-Số ca nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật không giảm

-Các hoá chất từ môi trường xâm nhập vào cơ thể, tích luỹ gây các tổn thương tại tế bào, bộ máy di truyền, gây nhiễm độc, ung thư (trẻ em nhạy cảm với hoá chất gấp 10 lần người lớn).

5.3.2. Ô nhiễm không khí ngoài trời :

-Khu công nghiệp, đô thị: Khói bụi, hơi khí độc từ các nhà máy không được xử lý, gây ô nhiễm.

-Các hơi khí độc như khí CO, CO2, NO2, chì, khói bụi do các phương tiện giao thông vận tải thải ra.

-Tại các làng nghề, công nghệ thủ công, lạc hậu, nơi sản xuất thường chật hẹp ngay tại hộ gia đình (nơi sản xuất đồng thời là nhà ở), chất thải, khí thải không được thu gom xử lý gây ô nhiễm cho khu vực dân cư làng nghề.

-Hậu quả của ô nhiễm không khí tại đô thị, khu công nghiệp, làng nghề làm tăng các bệnh liên quan ô nhiễm như các bệnh phổi, phế quản, tắc nghẽn, dị ứng…

5.3.3. Ngộ độc thực phẩm :

+ Đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng của toàn xã hội, người sản xuất đã sử dụng ngày càng nhiều các hoá chất trừ sâu diệt cỏ, phân bón hoá học, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng vật nuôi.

+Hậu quả là số vụ ngộ độc thực phẩm do bị ô nhiễm bởi các loại mầm bệnh, các loại hoá chất độc gia tăng

5.3.4. Tai nạn thương tích :

Đang gây ra những hậu quả lớn cho sức khoẻ cộng đồng.

-Tai nạn trong nhà : do bếp, do điện, do lửa

-Tai nạn trong các nhà máy do sản xuất, do cháy nổ, sập hầm lò

-Tai nạn thương tích do giao thông (đây là nguyên nhân gây thiệt hại lớn nhất hiện nay), do sét đánh, do đổ cây, đổ tường

-Tai nạn do tắm sông, suối, biển, do lũ lụt, đi rừng

-Tai nạn trong các đợt thiên tai, thảm hoạ

5.3.5. Biến động khí hậu thời tiết do môi trường suy thoái :

-Khai thác tài nguyên môi trường cạn kiệt, chặt phá rừng, làm thay đổi môi trường sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học, tiệt chủng nhiều loài động thực vật.

-Sự suy giảm tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính, thảm hoạ thiên nhiên ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ cộng đồng

+ Làm tăng tỷ lệ các bệnh ung thư da, các bệnh do thảm hoạ.

+Ước tính khoảng 70% dân số nước ta bị lũ đe doạ,

+Bão, lũ lụt, lở đất là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, kéo theo các bệnh dịch như tiêu chảy, tả, lỵ, sốt xuất huyết, sốt rét

+Là nguyên nhân gây đói nghèo, làm suy giảm sức khoẻ dân cư.

- **5.3.6. Lối sống không lành mạnh :**

-Lối sống không lành mạnh gây bệnh tim mạch, tăng đường huyết, suy nhược thần kinh… đang chiếm vị trí hàng đầu trong bệnh tật tại cộng đồng, nhất là tại các đô thị đang thay thế dần các bệnh nhiễm trùng truyền thống.

-**Hút thuốc lá :**

+ Theo WHO có khoảng 36 bệnh được biết là có liên quan tới hút thuốc lá (ung thư hầu họng, thực quản, phổi, gan, tuỵ, thận, dạ dày, bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, đột quỵ, xơ cứng động mạch, đẻ non, thiếu máu, xẩy thai, loãng xương, thấp cân, đần độn, chết lưu, viêm phế quản mãn, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính…).

+Tại Việt nam, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới thuộc loại cao nhất thế giới

+ WHO dự báo sẽ có khoảng 10% dân số Việt nam sẽ tử vong sớm do các bệnh liên quan đến hút thuốc và một nửa trong số đó sẽ tử vong ở độ tuổi lao động. Nếu không can thiệp giảm hút thuốc lá thì số chết do hút thuốc lá tại Việt nam sẽ cao hơn số chết do HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn cộng lại.

-**Uống bia rượu :**

+ Tiêu thụ bia rượu gắn liền với rất nhiều bệnh tật và các vấn đề xã hội như xơ - gan, ung thư gan, bệnh tim mạch , thần kinh tâm thần, bạo lực trong gia đình, xã hội, tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn giao thông), ước tính một nửa số vụ bạo lực trong gia đình do lạm dụng rượu.

-Ma tuý :

+Nghiện hút đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố lớn và các tỉnh biên giới.

+Tác động tiêu cực về sức khoẻ: nhiễm HIV/AIDS, viêm gan vi rút, bạo lực thương tích cho gia đình và xã hội.

+Đồng hành với ma tuý ngoài HIV/AIDS là các bệnh lây qua đường tình dục, tệ nạn mại dâm, tội phạm...

-**Dinh dưỡng :**

+Chế độ ăn uống vệ sinh, đầy đủ chất dinh dưỡng, cân đối, hợp lý là nền tảng cho sức khoẻ.

+ Thực tế dinh dưỡng ở Việt nam đang ở 2 thái cực : thiếu dinh dưỡng ở nhiều vùng sinh thái, nhất là các vùng khó khăn, đặc biệt ở trẻ em dưới 5 và thừa dinh dưỡng ở một bộ phận dân cư, nhất là tại các đô thị lớn, ở cả trẻ em và người lớn.

+Thiếu các yếu tố vi chất như thiếu i ốt, thiếu vitamin A thiếu sắt (ước tính có khoảng 50% phụ nữ mang thai và trên 60% trẻ dưới 2 tuổi bị thiếu máu do thiếu sắt)

+ Thực trạng thừa dinh dưỡng, béo phì đang có chiều hướng gia tăng tại các đô thị. Đây là nguy cơ cao cho các bệnh liên quan đến thừa dinh dưỡng như béo phì, tăng đường huyết, các bệnh tim mạch, ung thư vú, tỷ lệ béo phì ở học sinh 6-11 tuổi thành phố Hồ Chí Minh 22%, Hà nội 17%.

-Thể dục thể thao : Tập luyện thường xuyên tạo nên mộy lối sống lành mạnh, tăng cường sức khoẻ, dự phòng bệnh tật khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ.

-Hoà nhập với xã hội : Sự thích nghi, hoà nhập với môi trường luôn thay đổi hàng ngày có tác động tới sức khoẻ cá nhân và cộng đồng. Quá trình đô thị hoá, kinh tế thị trường, từ tư duy tập thể đến phát huy ý tưởng cá nhân… ảnh hưởng đến bệnh tật liên quan tới các stress tâm lý, sự hoà nhập, cách ly của mỗi cá nhân với cộng đồng.

6.Các bệnh tật liên quan đến môi trường

- Các bệnh đường tiêu hóa do vi sinh vật, ký sinh trùng: tả, thương hàn, lỵ, tiêu chảy, giun sán. Các mầm bệnh chủ yếu từ phân người, qua môi trường nước, thực phẩm gây bệnh cho người.

-Các bệnh do côn trùng tiết túc truyền bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật bản, dịch hạch, giun chỉ.

-Các bệnh về mắt, phụ khoa, ngoài da: do sử dụng nước bẩn

-Các bệnh do hoá chất và chất độc từ môi trường gây bệnh: nhiễm độc chì, đồng, thuỷ ngân, thuốc trừ sâu, ung thư...

-Các bệnh do lối sống: béo phì, đái tháo đường, tim mạch, suy nhược thần kinh, tai nạn

7. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khoẻ

7. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khoẻ

Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe là tổng hợp của các giải pháp kỹ thuật, hành chính nhằm bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm, để không gây tác hại cấp tính hay mạn tính đối với sức khỏe con người và các biện pháp bảo vệ người tiếp xúc, hạn chế phơi nhiễm với các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và giải quyết các hậu quả trên sức khỏe của người tiếp xúc.

7.1.Các biện pháp đối với môi trường (đất, nước, không khí, thực phẩm, nhà ở, bệnh viện, trường học, nơi công cộng…)

- Đánh giá môi trường : theo dõi, lấy mẫu, phân tích xác định các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, đánh giá mức độ ô nhiễm, xác định các nguồn gây ô nhiễm, đường truyền ô nhiễm. Kết quả đánh giá môi trường là căn cứ áp dụng các giải pháp làm giảm tác nhân ô nhiễm ngay tại nguồn thải và ngoài môi trường

- Thực thi các chính sách, chiến lược, các giải pháp hành chính, pháp luật về bảo vệ môi trường tại tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

7.2.Các biện pháp đối với người tiếp xúc (người lao động trong các ngành nghề, các cộng đồng dân cư bị ô nhiễm)

- Đánh giá tiếp xúc với ô nhiễm môi trường của người dân:

+ Sau khi phân tích, tính toán được mức độ ô nhiễm, cần ước tính ra liều tiếp xúc trung bình, liều tiếp xúc trung bình theo thời gian, liều tiếp xúc cao nhất. Đối chiếu liều tiếp xúc với các tiêu chuẩn cho phép để đưa ra nhận định về những hậu quả của môi trường trên sức khỏe.

+ Đối với các trường hợp không thể đo lường được mức độ tiếp xúc (định lượng) mà chỉ ước lượng được nguy cơ (định tính) bằng cách xác định nguy cơ là số người đã từng tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.

+ Mức độ ô nhiễm mà cộng đồng phải tiếp xúc càng cao (quá tiêu chuẩn cho phép), thời gian tiếp xúc càng dài thì nguy cơ càng cao.

- **Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lên sức khỏe :**

+ Thông thường ảnh hưởng của môi trường lên sức khỏe được xác định thông qua các chỉ số mắc bệnh, tử vong của một số bệnh đặc trưng hoặc một số bệnh không đặc trưng.

+ Có các yếu tố môi trường khó xác định tác hại trên sức khỏe do tính đặc hiệu thấp. Trong cùng một điều kiện tiếp xúc, cùng một liều tiếp xúc nhưng có những cá thể hoặc nhóm cá thể không hoặc ít bị ảnh hưởng hơn các cá thể hoặc nhóm cá thể khác. Vì vậy, đánh giá ảnh hưởng của môi trường lên sức khỏe phải dựa vào tính phổ biến, vào quy luật của số đông : dựa vào các số liệu thống kê về tình hình mắc bệnh, tử vong qua khám định kỳ, khám sàng lọc, điều tra dịch tễ học, phỏng vấn về các vấn đề sức khỏe của từng nhóm đối tượng…

+ Ảnh hưởng của môi trường lên sức khỏe thường biểu hiện với hiện tượng tảng băng nổi : chỉ có một vài trường hợp tử vong (phần nổi của tảng băng), còn phần lớn số người đang bị bệnh ở thể lâm sàng hoặc tiền lâm sàng chưa được phát hiện. Vì vậy, khi có một người bệnh được phát hiện, cần hình dung đã có rất nhiều người đang tiếp xúc quá mức với các yếu tố nguy cơ nhưng chưa có biểu hiện mắc bệnh. Trong cơ thể người tiếp xúc có thể đã có các rối loạn chức năng, rối loạn ở mức tế bào, chỉ phát hiện được bằng các xét nghiệm tế bào, gien, sinh hóa, sinh học phân tử.

- Khi xác định được những tác động của môi trường lên sức khỏe, cần xác định mối quan hệ nhân quả của tương tác này, từ đó đưa ra các biện pháp ưu tiên làm giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

7.3. Các nhiệm vụ của ngành y tế trong lĩnh vực sức khỏe môi trường

Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, ngành y tế có 10 nhiệm vụ trong lĩnh vực sức khỏe môi trường

7.3.1.Đề xuất và phổ biến các biện pháp dự phòng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Cung cấp các căn cứ khoa học và tham mưu cho chính quyền các chính sách, chiến lược, giải pháp bảo vệ sức khỏe, tránh các nguy cơ do ô nhiễm môi trường. Thông tin tới các bộ ngành, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cộng đồng dân cư về các vấn đề sức khỏe liên quan đến môi trường.

7.3.2.Nâng cao năng lực của cộng đồng trong xử lý các tác động của môi trường lên sức khỏe, trong đó bao gồm các giải pháp phòng ngừa bệnh tật do chính quyền địa phương và người dân thực hiện.

7.3.3. Tiến hành đánh giá các nguy cơ từ môi trường tác động lên sức khỏe, bao gồm các hoạt động theo dõi môi trường, phát hiện các yếu tố độc hại đối với sức khỏe từ môi trường sản xuất, môi trường sinh hoạt gia đình, sinh hoạt cộng đồng.

7.3.4. tiến hành giám sát dịch tễ học đối với các bệnh có liên quan đến môi trường. Thông báo hiện trạng cũng như các dự báo về tình hình sức khỏe và các yếu tố độc hại từ môi trường cho các cấp có thẩm quyền ra các chính sách trong phát triển kinh tế xã hội của vùng, của đất nước.

7.3.5. Đào tạo các cán bộ y tế dự phòng, y tế công cộng tại các tuyến và các cán bộ các ngành có liên quan.

7.3.6. Cung cấp các dịch vụ sức khỏe môi trường, triển khai các chương trình dự án về kiểm soát môi trường, kiểm soát sức khỏe độc lập hoặc phối hợp với các ngành nghề sản xuất khác.

7.3.7.Tham gia cùng các bộ ngành, địa phương trong ứng phó các thảm họa, tai biến môi trường tự nhiên hoặc do con người gây ra.

7.3.8. Phối hợp với các cơ quan để đưa ra các tiêu chuẩn cho phép về sức khỏe môi trường, xây dựng các văn bản có tính pháp quy về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7.3.9. Tham gia đánh giá tác động môi trường, chủ động đề xuất các biện pháp dự phòng, các quy trình theo dõi sức khỏe một cách có hệ thống.

7.3.10.Đề xuất và tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe môi trường và các giải pháp dự phòng ô nhiễm môi trường, phòng ngừa bệnh tật cho cộng đồng dân cư.